

PROCEDIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECCIOSOS

1. OBJETIVO.

Interrumpir la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa, a fin de prevenir el contagio entre los pacientes, y el personal hospitalario; así como el personal en contacto con el entorno del paciente y a familiares o visitantes.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia desde que el médico tratante sospecha paciente con diagnóstico de enfermedad infectocontagiosa, y termina cuando el médico realiza la suspensión del aislamiento ya sea el motivo de ingreso o ésta sea detectada durante el período de hospitalización y se le da el debido proceso de aislamiento de acuerdo con la patología identificada.

3. DEFINICIONES.

3.1 IAAS: Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), se definen de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), como aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital o Centro Sanitario, que no estaba presente, ni en período de incubación al momento de su ingreso y que pueden inclusive llegar a manifestarse después del alta del paciente.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 **Actualización:** Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UVEH).

4.2 **Ejecución:** Médico tratante, admisión, supervisión de enfermería, médico de guardia, enfermería, personal clínico/no clínico, laboratorio e intendencia y UVEH.

4.3 **Supervisión:** Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UVEH).

PROCEDIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECCIOSOS

5. DESARROLLO DEL PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	MÉDICO TRATANTE	Indica el ingreso de paciente, con su diagnóstico establecido.
5.2	ADMISIÓN	Realiza el trámite de ingreso administrativo y avisa a supervisión de enfermería. PR-CS-01
5.3	SUPERVISIÓN ENFERMERÍA	Revisa indicaciones y detecta paciente infeccioso o con sospecha de infección.
5.4		Determina habitación de aislamiento y medida precautoria a implementar (Contacto, Gota, aérea, MDRO). (FT-UV-05) Nota: En caso de tener duda avisa al departamento de UVEH.
5.5		Realiza visita e identifica paciente con sospecha clínica o con diagnóstico certero de paciente infeccioso y avisa al departamento de UVEH, Supervisión de enfermería y determina la media precautoria a implementar. (FT-UV-05)
5.6		Notifica al médico tratante del aislamiento en caso de no conocerlo.
5.7	MÉDICO DE GUARDIA	Coloca en la habitación medida precautoria correspondiente al ingreso de la habitación. (FT-UV-05)
5.8		Realizar higiene de manos durante los 5 momentos (IT-UV-01) y (IT-UV-04)
5.9		Colocar adecuadamente el equipo de protección correspondiente: ● Usar bata de manga larga (IT-UV-05) ● Colocación correcta del cubrebocas (IT-UV-06)
5.10		Manejo adecuado de los Residuos Peligrosos Biológicos e Infecciosos, así como desecho adecuado de punzocortantes.
5.11	ENFERMERÍA	Se deberá explicar al paciente y a sus familiares o visitantes la razón del aislamiento, así como la importancia de utilizar el equipo de protección, donde

PROCEDIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECCIOSOS

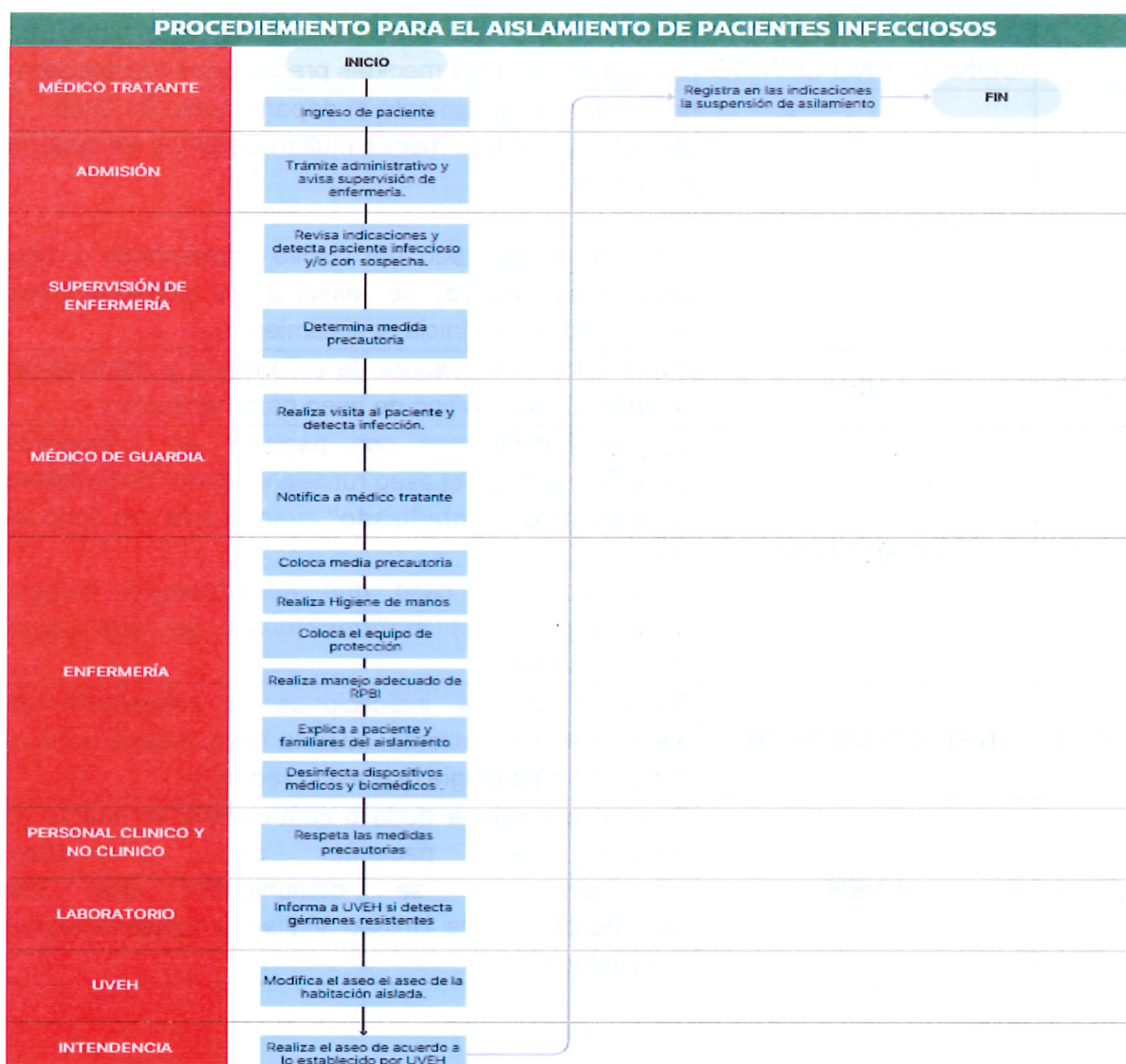
		solicitarlo y el manejo posterior a su uso, ejemplo: cubre boca, guantes. <i>Nota: el personal deberá explicar al familiar al familiar cómo se coloca el equipo de protección.</i>
5.12		Los dispositivos médicos que estén en contacto con el paciente deberán desinfectarse con frecuencia. (IT-JE-45)
5.13		Los equipos biomédicos serán desinfectados o esterilizados una vez que el paciente egrese del hospital. <i>Nota: en caso de que requiera quedar en "cultivo", UVEH los determinará.</i>
5.14	TODO PERSONAL CLINICO Y NO CLINICO	Todo personal que requiera ingresar a la habitación deberá respetar las medidas precautorias establecidas.
5.15	LABORATORIO	Informar inmediatamente al departamento de UVEH si detecta y/ aísla gérmenes multirresistentes en cultivos del paciente. <i>Nota: si el resultado del cultivo corresponde a una IAAS (caso nuevo) se avisa a los departamentos involucrados y se inicia el aislamiento.</i>
5.16	UVEH	Avisa a los supervisores de enfermería y médicos de guardia y modifica tipo de aseo para habitación
5.17	INTENDENCIA	En las habitaciones con paciente en aislamiento deberá realizarse el aseo rutinario y aseo "Exhaustivo Supervisado + Nebulizado" cuando éste sea dado de alta. <i>Nota: En dado caso que epidemiología detecte algunos gérmenes multirresistentes, se hará como aseo "Cultivo".</i>
5.18	MEDICO TRATANTE	Registrar en las indicaciones la suspensión de aislamiento del paciente, cuando haya desaparecido la condición o patología que así lo requiera.
5.19	UVEH	Si existiese alguna duda o controversia en cuanto al manejo del paciente con enfermedad infectocontagiosa se comunicarán con los responsables de la Unidad Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria.

PROCEDIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECCIOSOS

6. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Omisión del proceso por parte del personal clínico.	a. Capacitaciones al personal clínico de las medidas precautoria Inversa.
b. Brotes de infecciones por mal manejo del paciente infeccioso.	b. Asignación estratégica de habitaciones para pacientes y supervisión continua.

7. ANEXOS.



PROCEDIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECCIOSOS

7.2 Documentos de referencia.

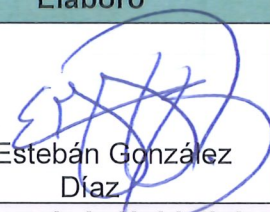
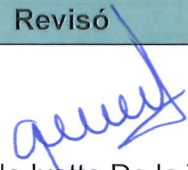
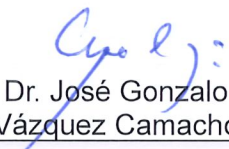
Nombre del documento	Código
Medidas precautorias	FT-UV-05
Instrucción de trabajo para la higiene de manos con agua y jabón.	IT-UV-01
Instrucción de trabajo para la higiene de manos con gel alcoholado.	IT-UV-04
Higiene de manos con gel alcoholado	IT-UV-04
Colocación correcta de bata	IT-UV-05
Colocación correcta del cubrebocas	IT-UV-06
Proceso para el abastecimiento de insumos para la higiene de manos	PR-UV-01
Desmontaje y sanitización de material	IT-JE-45
Limpieza y desinfección de habitaciones	IT-IN-01
Guía De Aplicación De La Estrategia Multimodal De La OMS, Para La Mejora De La Higiene De Manos (2010).	NA
Norma Oficial Mexicana Nom-045-Ssa2-2015, Para La Vigilancia Epidemiológica, Prevención Y Control De Las Infecciones Nosocomiales.	NA

PROCEDIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECCIOSOS

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	03/06/2021	Alta de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	08/09/2023	Modificación de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
03	26/09/2025	Actualización de procedimiento	Lic. Viridiana López Fajardo	Dr. Estebán González Díaz

9. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dr. Estebán González Díaz Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UEVH)	 Dra. Giselle Ivette De la Torre Garcia Jefatura de Calidad	 Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho Dirección Médica